四、并发症和相应治疗

（一）消化道出血

VS 食管胃底静脉曲张破裂出血(位置高):呕鲜血

1.原因：食管胃底静脉曲张破裂出血（最常见的并发症）、门脉高压性胃肠病（呕咖啡样血）、消化性溃疡、急性糜烂性出血性胃炎

屏障功能受损

鲜血:食管胃底静脉曲张破裂出血、贲门黏膜撕裂综合征

2.食管胃底静脉曲张破裂

①突发呕血（多为鲜血、量大）、黑便/柏油便，脾脏缩小、侧支循环减轻（腹水不会减少覆水难收），肠鸣音↑，肠源性氮质血症（易诱发肝性脑病），出血量＞800-1000ml 可休克

腹水不进展或进展速度变慢

肠内因素刺激肠壁

血红蛋白被肠道吸收

VS 消化性溃疡出血:闭塞性/增殖性动脉内膜炎→一般出血量小

②诊断食管胃底静脉曲张：胃镜

③治疗（3P 治生态、EVL 全都有）

收缩压＜90：补充血容量 平衡盐溶液
内镜曲张食管静脉套扎术 EVL（中等以下出血量） + 只用于治疗,不用于预防 生长抑素/奥曲肽（收缩内脏血管→减少门静脉血流量→降低门静脉压） 对全身血管都有收缩作用（也可用血管升压素/垂体加压素/特利加压素，但禁用于高血压、冠心病、心衰、孕妇）高官运衰
VS PPI在消化性溃疡中是首选PPI 抑制胃酸分泌、三代头孢预防感染、三腔二囊管（过渡）、TIPS 降低门脉压

PPI抑酸→改变了局部ph值→利于血小板聚集

④一级预防（未出血）：对因治疗、普萘洛尔/卡维地洛（非选择性 β-R 拮抗剂普卡）、EVL（中度食管静脉曲张）

还可以阻断α-R　阻断β2-R→血管收缩

轻度不用搞,重度搞不定

不适合结扎胃底的静脉曲张

⑤二级预防（已出血）：TIPS 等部分门体分流术、EVL 等断流术、注射栓塞剂等断流术、普萘洛尔/卡维地洛

（二乙医院被塞小费）

β-R拮抗剂

（二）感染

1.包括自发性细菌性腹膜炎、胆道/肠道/尿道/肺等感染

多为肠源性感染:门脉高压→肠粘膜淤血、水肿→肠粘膜屏障功能↓→细菌毒素移位入血→到达腹膜

2.自发性细菌性腹膜炎

（1）表现

①感染表现：发热（低热多见）、全腹腹膜刺激征/压痛反跳痛肌紧张（关键）

②腹水量迅速增加

主要看的指标("不会说谎")

③腹腔穿刺抽液：腹水性质介于渗出液和漏出液之间或为渗出液：SAAG＜11、细胞＞500×10^6/L 且以多个核细胞（中性粒细胞）为主。比重＞1.018、蛋白＞30g/L（有时比重＜1.018、蛋白＜30 可能是低蛋白血症）

VS 结核性腹膜炎以单个核细胞(淋巴细胞)为主

（2）治疗

小肠上皮细胞的能源物质

①补充谷氨酰胺：保护肠粘膜防止细菌和毒素移位 自发性腹膜炎多为肠源性感染,所以要保护肠黏膜

②早期足量用头孢哌酮、喹诺酮类等抗生素：主要针对 G-杆菌（大肠杆菌等）、并兼顾 G^+球菌；至少 2 周

原发性腹膜炎:腹腔内没有感染灶,出现了腹膜炎(如肝硬化的自发性腹膜炎)
继发性腹膜炎:腹腔内有病灶(如消化道穿孔导致的腹膜炎)

（三）肝肾综合征

1.机制：

①腹水：有效循环血量↓→肾血流↓→肾小球滤过率↓